CatchPoint 分工表（精简版，10/22）

报告顺序：**A → D → B → C → E**（换手 4 次，最后由 E 收尾），共约 16 分钟 + 5 分钟 Q&A。

顺序	角色	幻灯片	时间	负责范围（一句话）	要交付	Q&A 要能回答
1	**A 临床**	2–4 问题、现有方案、创新对照矩阵	约 3 分钟	病人为什么需要这个、别人做到哪	问题数据与出处；现有方案缺口；矩阵每格的文献依据	数据来源？为什么现有做法不够？
2	**D 控制**（Chuanhan）	5–7 三项贡献、控制架构与时序、必须踩哪 vs 能踩到哪	约 3.5 分钟	什么时候出手、出多少力	决策流程与时序图；最小推力规则；技术整合与数字一致性	跟 RobUST / MRBA 差在哪？延迟怎么处理？
3	**B 机构**	8–13 缆绳接口与前闸门、爆炸图、防翻倒、三情境（渲染 + 物理视频）	约 3 分钟	硬件能不能轻推、接住、不翻倒	D3 CAD；受力图；张力 / 刹车 / 翻倒裕度表	300 N 怎么来？为什么要外伸脚？
4	**C 传感**	14–18 传感与估测、物理患者、物理 demo、行走 demo（held-out 测试）	约 3 分钟	机器人怎么知道状态，以及整套系统跑起来的样子	传感配置与延迟预算；校正流程；demo 视频	用什么传感器？物理 demo 公平吗？
5	**E 仿真**	19–22 仿真结果、限制、临床验证计划、总结	约 3.5 分钟	证据有多强、还缺什么、下一步怎么验证	冻结的结果数字（含分母与信赖区间）；限制与验证计划（与 A 一起准备）	模型多简化？有没有 held-out 测试？

共同规则

- 只引用冻结的证据档，数字附分母（例如「814 次触发吊带中 805 次接住」）。
- 不宣称原型、不宣称临床效果；创新一律写「据我们所知」。
- 每人重跑或读懂自己那部分，并能脱稿讲完自己那段。

时程：10/24 对齐数字 → 10/28 各段定稿 → 10/29 合并 → 10/31 稽核 → 11/1–2 彩排两次 → **11/3 交件。**